

Тема: Роль и место первой помощи в критических и чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по оказанию первой помощи

Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? {

~ Разрешено

= Запрещено

~ Разрешено в случае крайней необходимости

~ Разрешено, если есть у пострадавшего в наличии

}

При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? {

~%25% ожоги

~%25% травмы различных областей тела

~%25% инородные тела верхних дыхательных путей

~%25% отморожения

~%-100% высокая температура

}

При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? {

~%25% отсутствие сознания

~%25% отравление

~%25% наружные кровотечения

~%-50% боли в животе

~%25% остановка дыхания и кровообращения

~%-50% боли в груди

}

Первая помощь оказывается во всех нижеперечисленных случаях, кроме следующего: {

~ отсутствие сознания, дыхания и кровообращения;

~ травмы различных областей тела и наружные кровотечения;

~ инородные тела в верхних дыхательных путях;

~ ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;

~отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;

~ отравления;

= острые инфекционные заболевания.

}

Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется: {

~ до доставки пострадавшего в медицинскую организацию;

~ до прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия;

~ до улучшения его самочувствия;

= до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи.

}

У мужчины 55 лет на фоне психоэмоционального стресса возникли сильные жгучие боли за грудиной. В чем будет заключаться первая помощь? {

- ~ придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия;
 - ~ уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, дать таблетку нитроглицерина под язык, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия;
 - ~ предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать принять таблетку нитроглицерина под язык, проводить пострадавшего до поликлиники;
 - ~ позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие лекарства он принимает, дать ему принять эти лекарства, уложить, обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в течение часа вызвать скорую медицинскую помощь;
 - = придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить больному принять назначенные ему лекарства.
- }

Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего: {

- ~ оценить его общее состояние;
 - = обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального);
 - ~ попытаться обнаружить ранения различных областей тела;
 - ~ определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи.
- }

К мероприятиям первой помощи относится все нижеперечисленное, кроме следующего: {

- ~ мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
- ~ определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего;
- ~ мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации;
- = мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и шоке;
- ~ мероприятия по осмотру пострадавшего, остановке наружного кровотечения и оказанию первой помощи при травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего;
- ~ придание пострадавшему оптимального положения тела и контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);
- ~ оказание психологической поддержки пострадавшему и передача его бригаде скорой медицинской помощи.

}

Выберите последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании: {

- = голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки;
 - ~ грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот;
 - ~ голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги;
 - ~ ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот.
- }

После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи водителю необходимо, прежде всего, осуществлять следующие действия: {

- ~ продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда прибудет бригада, для определения необходимости в самостоятельной транспортировке пострадавших;
 - = продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую поддержку;
 - ~ для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их попутным или служебным автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской помощи;
 - ~ подготовить попутный или служебный автотранспорт к госпитализации пострадавших.
- }

Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие: {

- ~ поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет, чтобы по его запотеванию определить наличие дыхания;
 - ~ поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или перышко, чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания;
 - = наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки у пострадавшего;
 - ~ положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь ощутить дыхательные движения пострадавшего.
- }

При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния следует прежде всего: {

- = произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его;
- ~ опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы;

- ~ дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания;
- ~ попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды.

}

Для оценки сознания пострадавшего следует выполнить следующие действия: {

- ~ похлопать по щекам пострадавшего, надавить на болевые точки;
- = потормошить за плечи, спросить, что с ним и нужна ли ему помощь;
- ~ окликнуть пострадавшего громким голосом;
- ~ поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом.

}

Какой метод используется для открытия дыхательных путей пострадавшему без сознания: {

- ~ запрокидывание головы с приподнятием шеи;
- ~ приподнятие головы с поддержкой шеи;
- ~ нейтральное положение с фиксацией подбородка;
- = запрокидывание головы с приподнятием подбородка.

}

Для сохранения проходимости дыхательных путей пострадавшего без сознания надо перевернуть: {

- ~ в безопасное положение на спине, ноги приподнять на 30 см;
- ~ на живот, подложив что-нибудь под голову;
- = в устойчивое боковое положение на бок, лицом к себе;
- ~ ни в коем случае не трогать пострадавшего!

}

Подробный осмотр пострадавшего проводится в следующем порядке: {

- ~ лицо, шея, грудь, спина, голова, живот, таз, конечности;
- ~ грудь, спина, голова, шея, живот, таз, конечности;
- = голова, шея, грудь, спина, живот, таз, конечности;
- ~ голова, грудь, спина, живот, верхние конечности, нижние конечности.

}

Если при попытке оказать помощь пострадавшему его поведение угрожает вашей собственной безопасности, то вы должны: {

- ~ постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить нанесение вам увечья;
- ~ попытаться успокоить пострадавшего, взяв его за руку, и обратиться к нему тихим голосом;
- ~ говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился;
- = отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, по необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и ждать ее прибытия.

}

Вы определили, что у пострадавшего отсутствует сознание. Когда необходимо вызвать скорую медицинскую помощь? {

= сразу;

~ после проверки дыхания;

~ после оказания необходимой первой помощи;

~ не имеет большого значения.

}

Как часто следует пополнять аптечку первой помощи (автомобильную)? {

~ 1 раз в год;

~ 1 раз в 1,5 года;

~ 1 раз в 3–5 лет;

= по мере израсходования ее компонентов.

}

При наличии у пострадавшего признаков артериального кровотечения из области запястья предпочтительно: {

= выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку;

~ наложить кровоостанавливающий жгут ближе к ране;

~ вложить бинт в локтевую ямку и выполнить максимальное сгибание конечности в суставе.

~ согнуть конечность в локтевом суставе

}

Первую помощь обязаны оказывать: {

~ лица, с медицинским образованием

~ любые очевидцы происшествия

~ лица, прошедшие тренинги по первой помощи

= сотрудники соответствующих служб, находящиеся при исполнении

}

При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее:

~%50% причину травмы

~%33.33333% наличие крупных ран

~%33.33333% наличие дыхания

~%33.33333% наличие сознания

~%50% проходимость дыхательных путей

}

Проведение первичного осмотра, пострадавшего начинается с: {

~ проверки наличия дыхания

~ проверки наличия пульса

~ призыва на помощь

= проверки наличия сознания

}

Если у пострадавшего отсутствует сознание, то следующее ваше действие будет: {

- ~ проверка наличия дыхания
- ~ проверка наличия пульса
- = призыв на помощь
- ~ проверка наличия ран
- }

Алгоритм оказания первой помощи начинается с: {

- = осмотра места происшествия
- ~ первичного осмотра пострадавшего
- ~ вызова специалистов
- ~ вторичного осмотра
- }

По российским законам может быть применено наказание в случае, если: {

- ~ первая помощь оказана неправильно
- ~ вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали
- = вы оставили пострадавшего без помощи
- ~ вы позвали на помощь, но сами ничего не делали
- }

Если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс и дыхание, то его надо: {

- = повернуть на бок (там, где нет повреждений)
- ~ не трогать его
- ~ повернуть на спину (если нет повреждений)
- ~ привести в чувства любым способом
- }

К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: {

- ~%25% осмотр места происшествия
- ~%25% первичный осмотр
- ~%25% вызов скорой помощи
- ~%25% вторичный осмотр
- ~%-100% оставления места происшествия
- }

Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: {

- = поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов
- ~ диагностика причины травмы пострадавшего
- ~ оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме
- ~ все выше сказанное
- }

Признаки жизни: {

~ наличие сохраненного дыхания.
~ наличие сохраненного дыхания, наличие сердечной деятельности.
~ наличие сохраненного дыхания, наличие реакции зрачков на свет.
= наличие сохраненного дыхания, наличие сердечной деятельности, наличие реакции зрачков на свет.
}

Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи: {

~%25% Для прекращения действия повреждающих факторов
~%25% Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего
~%25% Для поддержания жизни пострадавшего
~%25% Для предупреждения развития тяжелых осложнений
~%-100% Для лечения острых заболеваний
}

«Золотой час» — это: {
=Время с момента получения травмы до поступления в больницу
~Время с начала оказания помощи до поступления в больницу
~Время с момента транспортировки пострадавшего
~Время с момента приезда скорой помощи
}

«Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается: {
~ С момента начала оказания помощи
~ С момента транспортировки пострадавшего
= С момента получения травмы
~ С момента приезда скорой помощи
}

Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи. {
~%25% Обеспечение безопасного оказания помощи.
~%25% Остановка наружного кровотечения.
~%25% Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.
~ %25% Сердечно-легочная реанимация.
~%-100% транспортировка больного
}

Укажите, с чего начинают оказание первой помощи. {
=Обеспечение безопасного оказания помощи.
~Остановка наружного кровотечения.
~Обеспечение проходимости дыхательных путей.
~Проведение простейших противошоковых мероприятий.
~Сердечно-легочная реанимация.
}

Перечислите сведения, которые необходимо сообщить диспетчеру при вызове скорой медицинской помощи в случае ДТП. {

~%25% По возможности точный адрес места происшествия и ориентиры места ДТП.

~%25% Характер происшествия (столкновение, переворачивание, наезд)

~%25% Количество пострадавших, зажатие пострадавших.

~%25% Номер телефона, с которого был сделан вызов скорой медицинской помощи, Ф.И.О. звонившего.

~%-100% Характер повреждений.

}

Укажите порядок сообщения информации диспетчеру скорой медицинской помощи. {

= Адрес места происшествия. Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших.

~ Наличие пострадавших. Характер происшествия. Время происшествия. Адрес места происшествия.

~Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших. Адрес места происшествия.

~ Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших.

}

Какие сведения о пострадавших в ДТП необходимо сообщить в первую очередь диспетчеру скорой медицинской помощи. {

~%33.33333%Количество пострадавших, в том числе детей.

~%-100% Зажатие пострадавших.

~%33.33333%Наличие беременных женщин.

~%33.33333%Наличие пожилых людей.

}

Первую помощь имеют право оказывать: {

~%20%Прохожий.

~%20% Водитель.

~%20%Сотрудник ГИБДД.

~ %20%Спасатель.

~%-100%Никто, кроме врача.

}

Выберите верную последовательность мероприятий первой помощи в ДТП. {

~ Провести осмотр пострадавших; оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь; обеспечить собственную безопасность.

=Обеспечить собственную безопасность и безопасность пострадавших; вызвать скорую медицинскую помощь; провести осмотр пострадавших; оказать первую помощь.

~Оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь; обеспечить собственную безопасность.

~Оказать первую помощь, оценить состояние, обеспечить собственную безопасность

}

При оказании первой помощи в первую очередь необходимо: {

~Немедленно оказать первую помощь пострадавшему.

=Обеспечить безопасность оказания помощи.

~Оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь.

~Позвонить в скорую помощь

}

Пострадало два человека: у одного из пострадавших «признаки жизни» не определяются, у другого определяется наружное кровотечение. Какому из пострадавших необходимо оказать помощь в первую очередь? {

~Пострадавшему без «признаков жизни».

= Пострадавшему с наружным кровотечением.

~ Пострадавшему, кто находится ближе к спасателю.

~Пострадавшему, который позвал

}

Укажите последовательность «спасательных вопросов». {

~Что? Где? Когда? Кто? Как?

=Где? Что? Когда? Кто? Как?

~Кто? Что? Где? Когда? Как?

~Когда? Как? Что? Почему? Кто?

}

Вы оказываете помощь пострадавшим. В салоне пострадавшего автомобиля находится три человека: Водитель — без сознания. У пассажира, рядом с водителем — открытая рана предплечья, сильного кровотечения из раны нет. На заднем сиденье — ребенок 6 лет, плачет. Видимых повреждений у ребенка нет. Кому из пассажиров вы окажите помощь в первую очередь? {

~ Водителю.

~Пассажиру, сидящему на переднем сиденье.

=Ребенку.

~ Вызвать скорую

}

Тактические приемы оказания первой помощи пострадавшему с острой психической травмой (выраженным агрессивным поведением). {

~%33.33333%Обеспечение безопасности пострадавшего.

~%33.33333%Обеспечение безопасности окружающих.

~%33.33333%Обеспечение собственной безопасности.

~%-100% Вызов скорой помощи

}

Стресс — это: {

=Состояние выраженного эмоционального напряжения, возникающее у человека в ответ на сильное внешнее воздействие, как приспособление организма к новым условиям.

~ Состояние пострадавшего после тяжелой травмы, сопровождающееся нарушением сознания.

~Состояние выраженного эмоционального напряжения.

~ Приспособительная реакция организма, после тяжелой травмы.

}

Избыточный стресс, возникающий у пострадавшего, может вызвать: {

~%33.33333%Острые психические реакции.

~%33.33333%Панику на месте происшествия.

~%-100% Сонливость.

~%33.33333%Посттравматические расстройства здоровья у пострадавших.

}

Острые психические реакции у пострадавших проявляются в виде следующих состояний: {

~%25%Истерика.

~%25% «Нервный озноб».

~%25%Ступор.

~%25%Агрессивное поведение.

~%-100% Сонливость.

}

Укажите варианты агрессивного поведения пострадавших с острой психической травмой: {

~%33.33333%Гнев.

~%33.33333%Стремление к самоповреждению.

~%-100% «Нервный озноб».

~%33.33333%Выраженное двигательное возбуждение.

}

Ступор проявляется у пострадавших с острой психической травмой как: {

~ Сонливость.

~«Нервный озноб».

=Безразличие к ситуации.

~Отсутствие сознания.

}

Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике. {
~Оцепенение.
= «Театральное» поведение.
~ Агрессивность.
~ Плаксивость
}

Истерика проявляется у пострадавших с острой психической травмой как: {
~%33.33333%Театральное поведение.
~%-100% «Нервный озноб».
~%33.33333%Рыдания и крик.
~%33.33333%Выраженное двигательное возбуждение.
}

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего с истерикой. {
~%-50%Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть.
~%50%Лишить пострадавшего внимания окружающих.
~%-50%Заставить пострадавшего выполнить конкретное обучение.
~%50%Говорить тихо, медленно и четко.
}

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего, находящегося в ступоре: {
~%50%Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть.
~%-50%Лишить пострадавшего внимания окружающих.
~%-50%Заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение.
~%50%Говорить тихо, медленно и четко.
}

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего с агрессивным поведением. {
~Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть.
~ Лишить пострадавшего внимания окружающих.
= Заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение.
~ Говорить тихо, медленно и четко
}

Пострадавших с острой психической травмой можно привлекать к оказанию помощи. {

- ~ Пострадавших с острой психической травмой ни в коем случае нельзя привлекать к оказанию помощи!
 - = Пострадавших с острой психической травмой можно привлекать к оказанию помощи, давая простые поручения: «принеси, отнеси, поддержи, передай, посмотри, встретить».
 - ~ Пострадавший с острой психической травмой должен лежать неподвижно
 - ~ Пострадавший с острой психической травмой должен оказывать первую помощь
- }

Перечислите, от чего зависит тяжесть острой психической травмы у пострадавшего. {

- ~%25%Состояние общего здоровья пострадавшего.
 - ~%25%Масштабность последствий происшествия.
 - ~%25%Темперамент пострадавшего.
 - ~%25%Тяжесть полученных физических травм.
 - ~%-100%От оказанной первой помощи
- }

При оказании первой помощи пострадавшему ребенку, необходимо: {

- ~%25%Установить с ребенком словесный и тактильный контакт.
 - ~%25%Дать мягкие игрушки, чтобы отвлечь от общего осмотра и манипуляций.
 - ~%25%По возможности привлечь родственников и знакомых к оказанию помощи.
 - ~%-100%Обязательно изолировать ребенка от родителей или родственников.
 - ~%25%Привлечь к оказанию помощи самого пострадавшего ребенка.
- }

Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи оставить ребенка одного. {

- = Нет, ни в коем случае.
 - ~ Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана.
 - ~ Можно, если ребенок спокоен.
 - ~ Можно если ребенок в сознании
- }

Оказывать психологическую поддержку пострадавшим могут: {

- ~%-100%Ребенок.
 - ~%25%Спасатель.
 - ~%25%Водитель.
 - ~%25%Психолог.
 - ~%25%Случайный прохожий.
- }

При оказании первой помощи пострадавшим с острыми психическими расстройствами необходимо: {

~%33.33333%Успокоить и установить словесный контакт с пострадавшим.

~%33.33333%Дать теплое сладкое питье.

~%33.33333%Вызвать скорую медицинскую помощь.

~%-100%Дать обезболивающий препарат.

}

Перечислите приемы психологического воздействия на пострадавшего с острой психической травмой. {

~%33.33333%Представиться пострадавшему.

~%33.33333%Объяснить свои действия по оказанию помощи.

~%33.33333%Установить и поддерживать с пострадавшим словесный контакт.

~%-100%Дать обезболивающий препарат.

}

Перечислите методы психологического воздействия на пострадавших с острой психической травмой. {

~%50%Вербальный.

~%50%Невербальный.

~%-50%Тактильный

~%-50%Визуальный

}

Вербальный метод психологического воздействия заключается в следующем: {

=Установление и поддержание словесного контакта.

~Установление и поддержание визуального и тактильного контактов.

~Установление и поддержание визуального контакта

~Установление и поддержание тактильного контактов.

}

Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в следующем: {

~Установление и поддержание словесного контакта.

=Установление и поддержание визуального и тактильного контакта.

~Установление словесного контакта.

~Поддержание словесного контакта

}

Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим: {

~%50%Наблюдение за состоянием пострадавшего.

~%-50%. Поддержание разговора с пострадавшим.

~%50%Для оказания психологической помощи .

~%-50%Установление словесного контакта.

}

Перечислите признаки утомления: {

~%25%Снижение скорости ответных реакции.

~%25%Раздражительность, нарушение сна, головные боли

~%25%Снижение физической активности.

~%25%Снижение умственной активности.

~%-100%Улучшение памяти.

}

При оказании первой помощи необходимо работать в перчатках. {

=Да, в любом случае.

~ Да, если пострадавший является асоциальным.

~ Только при оказании первой помощи ВИЧ-инфицированным лицам.

~Толь при оказании помощи молодым

}

При оказании первой помощи на кожу спасающего случайно попала кровь пострадавшего. Укажите верную последовательность мер профилактики инфекций, передающихся с кровью (ВИЧ-инфекция, гепатиты и др.). {

~ Тщательно промыть загрязненные кровью участки кожи теплой водой с мылом.

~ Двукратно вымыть с мылом под проточной водой загрязненные кровью участки кожи, затем обработать 70 % этиловым спиртом.

= В течение 30 секунд обработать загрязненные кровью участки кожи 70 % этиловым спиртом; двукратно вымыть с мылом под проточной водой; повторно обработать 70 % этиловым спиртом.

~промыть рану холодной водой

}

Тема: Базовая сердечно-легочная реанимация

Признаки жизни: {

~%50%наличие пульса на артериях;

~%-33.33333%наличие симптома «кошачьего глаза»;

~%-33.33333%трупное окоченение;

~%-33.33333%помутнение и высыхание роговицы глаз;

~%50%наличие реакции зрачков на свет

}

Признаки жизни: {

~%-33.33333%помутнение и высыхание роговицы глаз

~%-33.33333%наличие симптома «кошачьего глаза»;

~%-33.33333%трупное окоченение;
~%50%наличие дыхания;
~%50%наличие сердцебиения
}

Явные признаки смерти: {
~%50%помутнение и высыхание роговицы глаз;
~%50%наличие симптома «кошачьего глаза»;
~%-33.33333% наличие пульса на артериях;
~%-33.33333% наличие дыхания;
~%-33.33333% наличие сердцебиения
}

Периоды терминального состояния: {
~%33.33333% предагония;
~%-25% биологическая смерть;
~%-25% возбуждение;
~%33.33333% клиническая смерть;
~%33.33333% агония;
~%-25% торможение;
~%-25% асфиксия.
}

Признаки агонии: {
~%-33.33333%зрачки вяло реагируют на свет;
~%-33.33333%артериальное давление низкое;
~%50% артериальное давление не определяется;
~%50% пульс определяется только на сонных артериях;
~%-33.33333%кожа обычной окраски.
}

Признаки клинической смерти: {
~%-25% сознание сумеречное с периодами длительного отсутствия;
~%33.33333%сознание отсутствует;
~%33.33333%дыхание отсутствует;
~%33.33333%дыхание очень редкое в виде судорожных вдохов;
~%-25% пульс на сонной артерии не определяется;
~%-25% пульс определяется периодически только на сонных артериях;
~%-25% артериальное давление низкое.
}

Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: {
= 5;
~ 10;
~ 15;

~ 20;
~ 30.
}

Продолжительность предагонии составляет: {
~ несколько минут;
~ до 1 часа;
~ до 12 часов;
~ до суток;
= от нескольких часов до нескольких суток.
}

Показания для проведения реанимационного пособия: {
~%33.33333%внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке;
~%33.33333%утопление;
~%-25онкологические заболевания;
~%-25тяжелая сердечная недостаточность;
~%-25трупное окоченение;
~%33.33333%поражение электрическим током;
~%-25хроническая почечная недостаточность.
}

Противопоказания для проведения реанимационного пособия: {
~%-25внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке;
~%-25утопление;
~%33.33333%онкологические заболевания;
~%33.33333%тяжелая сердечная недостаточность;
~%33.33333%трупное окоченение;
~%-25поражение электрическим током;
~%-25острый инфаркт миокарда.
}

Возможные осложнения искусственных вдохов: {
~%-33.33333%открытый пневмоторакс;
~%50% попадание воздуха в желудок;
~%-33.33333%западение языка;
~%-33.33333%разрыв легкого у ребенка;
~%50%разрыв аорты.
}

Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: {
~%50% сужение зрачков;
~%-33.33333%появление зрачкового рефлекса;
~%-33.33333%появление самостоятельного дыхания;

~%50% появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца;
~%-33.33333%появление кашлевого рефлекса.
}

Продолжительность реанимации (если не удастся запустить работу сердца)
составляет ... мин: {
~ 10;
~ 20;
= 30;
~ 40;
~ 60.
}

Осложнения закрытого массажа сердца: {
~%-33.33333%попадание воздуха в желудок;
~%-33.33333%разрыв легкого;
~%50% травма легких, сердца;
~%50% перелом ребер;
~%-33.33333%перелом позвоночника.
}

Особенности реанимации у детей первого года жизни: {
~%50% нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов;
~%-33.33333%искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»;
~%50%компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев;
~%-33.33333%компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой;
~%-33.33333%объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл.
}

Особенности реанимации у детей первого года жизни: {
~%-33.33333%при проведении искусственных вдохов запрокинуть голову;
~%50% искусственные вдохи проводят одновременно и в рот, и в нос;
~%-33.33333%компрессии проводят двумя руками;
~%-33.33333%компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой;
~%50% объем искусственного вдоха равен объему полости рта.
}

Комплекс реанимационных мероприятий необходимо проводить до по- явления у пострадавшего: {
~ двигательной активности;
~ ясного сознания;
~ членораздельной речи;
= признаков оживления;
~ аппетита.
}

О наступлении клинической смерти можно говорить при появлении у пострадавшего: {
~ на теле темных пятен;
~ закатывании глазных яблок;
~ высыхании глазных яблок;
~ отсутствию сухожильных рефлексов;
= остановки кровообращения.
}

Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель: {
~2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала
=2 вдоха искусственного дыхания после 30 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала
~2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала
~1 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала
}

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо {
=повернуть пострадавшего на бок и надавить кулаками ниже пупка
~приподнять ноги, надавить ладонями на грудину
~не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха
~согнуть ноги в коленных суставах и надавить на область пупка
}

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) {
~%33.33333%отсутствие сознания
~%33.33333%нет реакции зрачков на свет
~%33.33333%нет пульса на сонной артерии
~%-50%появление трупных пятен
~%-50%деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами
}

Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно) {
~%-33.33333%отсутствие сознания

~%-33.33333%нет реакции зрачков на свет
~%-33.33333%нет пульса на сонной артерии
~%33.33333%появление трупных пятен
~%33.33333%деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами
~%33.33333%высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)
}

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии {

~15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
~30 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
~10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
=30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания
~5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания
}

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти): {
~первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего.

~первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя.

~ первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего .

~первый спасатель вызывает скорую помощь. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
}

В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего? {

= Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца).

~ Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких)

~ Проведение НМС (непрямого массажа сердца)

~проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца)
}

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? {

~ Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча

= Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота

~ Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет значения.

~ Давление руками на грудину выполняют, обхватив кулак одной руки ладонью другой. Направление пальцев не имеет значения
}

Когда производится вызов скорой медицинской помощи: {

~ непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим;
~ сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия;
= после определения примерного количества и состояния пострадавших;
~ сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия.
}

Частота надавливания при проведении компрессии грудной клетки составляет: {

~ 60–80 в 1 минуту;
~ 40–50 в 1 минуту;
= не менее 100 в 1 минуту;
~ 80–90 в 1 минуту;
~ 60 в 1 минуту.
}

При определении признаков жизни у пострадавшего проверяются: {

~ признаки сознания;
~ признаки сознания и дыхания;
= признаки сознания, дыхания и кровообращения;
~ признаки сознания, дыхания и кровообращения, реакция зрачков на свет.
}

Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации контролируется по следующему признаку: {

= начало подъема грудной клетки;
~ начало подъема живота;
~ максимальное раздувание грудной клетки;
~ появление сопротивления при выполнении вдоха.
}

В каких ситуациях следует приступить к сердечно-легочной реанимации? {

~ при отсутствии у пострадавшего признаков сознания;

= при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения;

~ в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут;

~ при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти.

}

Что следует сделать в случае длительного выполнения реанимационных мероприятий и возникновении физической усталости у человека, оказывающего помощь? {

~ прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, если с момента их начала прошло более 30 минут;

= привлечь помощника к осуществлению реанимационных мероприятий;

~ уменьшить частоту надавливаний на грудину;

~ снизить глубину надавливания на грудину;

~ констатировать биологическую смерть пострадавшего, отметив это в соответствующей документации.

}

Качественные вдохи искусственного дыхания выполняются при соблюдении следующего условия: {

~ максимально возможная скорость вдыхания;

~ максимально возможный объем вдоха;

= качественное открытие дыхательных путей;

~ качественная очистка полости рта.

}

При появлении признаков жизни у пострадавшего, которому проводилась сердечно-легочная реанимация, необходимо выполнить следующие действия: {

= придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать состояние пострадавшего;

~ продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью;

~ позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи;

~ прекратить проведение сердечно-легочной реанимации.

}

Для открытия дыхательных путей пострадавшего необходимо: {

~ запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, а другую подложить под шею пострадавшего;

~ запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя пальцами подняв подбородок;

= очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом;

~ удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой полости;

~ расстегнуть стягивающую одежду, галстук, воротник.

}

Давление на грудину при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему осуществляется следующим образом: {

~ кулаком одной руки;

~ ладонью одной руки;

~ ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест;

= двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над другой с выпрямленными пальцами.

}

Сердечно-легочная реанимация в объеме искусственного дыхания и надавливаний на грудную клетку может не проводиться в следующих случаях: {

~ при наличии у пострадавшего переломов нижней челюсти;

~ при наличии у пострадавшего травм грудной клетки;

= при наличии у пострадавшего травмы, явно не совместимой с жизнью (например, отрыв головы);

~ при наличии у пострадавшего длительно существующего хронического, например, онкологического заболевания;

~ при отсутствии возможности вызова скорой медицинской помощи;

~ при отсутствии у человека, оказывающего первую помощь, аптечки или укладки.

}

Глубина надавливания при проведении компрессий грудной клетки при сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему составляет: {

~ 4–5 см;

= 5–6 см;

~ 3–4 см;

~ 2–3 см.

}

Сердечно-легочная реанимация выполняется до нижеперечисленных моментов, кроме: {

~ прибытия скорой медицинской помощи;

~ появления явных признаков жизни у пострадавшего;

~ появления собственной усталости;

= истечения 30 минут с момента начала реанимации.

}

При отсутствии сознания у пострадавшего с признаками самостоятельного дыхания следует сделать следующее: {

~ положить пострадавшему под голову валик из одежды, вызвать скорую медицинскую помощь;

~ подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив сгибание шейного отдела позвоночника;

= придать пострадавшему устойчивое боковое положение;
~ повернуть пострадавшего на живот.
}

Качественное искусственное дыхание методом «рот ко рту» может осуществляться при следующих условиях: {
~ голова пострадавшего в нейтральном положении, нос зажат;
~ голова пострадавшего запрокинута, ротовая полость очищена;
= голова пострадавшего запрокинута, нос зажат, ротовая полость очищена;
~ голова может быть в любом положении, нос зажат.
}

Во время проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшего появились признаки жизни, в том числе и самостоятельное дыхание. Какое действие необходимо предпринять: {
~ сообщить диспетчеру скорой медицинской помощи о том, что состояние пострадавшего улучшилось;
~ прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, продолжив наблюдение за пострадавшим;
~ придать пострадавшему удобное для него положение;
= придать пострадавшему устойчивое боковое положение.
}

При проведении искусственного дыхания «рот-ко-рту» отмечается, что воздух не поступает в легкие, грудная клетка не поднимается. Какие действия следует предпринять в первую очередь: {
~ попытаться очистить ротовую полость;
~ выполнить искусственное дыхание методом «рот-к-носу»;
~ извлечь изо рта пострадавшего вставные челюсти;
~ увеличить силу и продолжительность вдувания;
= более тщательно запрокинуть голову.
}

При повторном осмотре пострадавшего, если у него есть сознания, то надо: {
~%25% осмотреть и опросить пострадавшего
~%25% обработать раны при наличии
~%25% опросить свидетелей
~%25% контролировать состояние
~%-100% оставить пострадавшего и уйти
}

При повторном осмотре пострадавшего, если у него нет сознания, но есть дыхание и пульс, то надо: {
~%25% придать оптимальное положение
~%25% обработать раны при наличии

~%25% опросить свидетелей и осмотр пострадавшего
~%25% контролировать состояние
~%-100%приступить к СЛР
}

Глубину, на которую должна прогибаться грудина при непрямом массаже сердца: {
~ 2-3 см
~ 3-4 см
= 4-5 см
~ 6-7 см
}

Массаж сердца проводится: {
~ на верхней части грудины.
~ на грудной клетке с левой стороны.
= на границе средней и нижней трети грудины.
~ на грудной клетке с правой стороны
}

К первым признакам биологической смерти относят: {
~ отсутствие сознания и пульса
~ отсутствие пульса и дыхания
= симптом «кошачьего глаза»
~нитевидный пульс и отсутствие дыхания
}

Период собственно клинической смерти начинается с момента прекращения кровообращения и длится ... {
= 4-5 минут
~ 2-3 минуты
~ 10-15 минут
~ до 1,5 часов
}

К признакам клинической смерти относятся: {
~%50% остановка дыхания и сердечной деятельности
~%-50% отсутствие пульса на лучевой артерии
~%50% широкий зрачок, не реагирующий на свет
~%-50% широкий зрачок, хорошо реагирующий на свет
}

Признаки биологической смерти: {
~ остановка дыхания и сердечной деятельности
~ зрачок не реагирует на свет

= трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»
~ резкое снижение (отсутствие) мышечного тонуса, трупные пятна, «кошачий глаз»
}

Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации: {
= на спине на ровной непрогибающейся поверхности
~ на спине на кровати
~ оставить то, в котором он был обнаружен
~ роли не играет
}

К признакам эффективности реанимационных мероприятий относятся: {
~%50% появление пульсации на сонных артериях синхронно с закрытым массажем сердца
~%50% появление самостоятельной пульсации на сонных артериях
~%50% расширение зрачка с появлением реакции зрачка на свет
~%50% сужение зрачка с появлением реакции зрачка на свет
}

Искусственное дыхание проводится в случаях: {
= когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, клинической смерти.
~ когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, появлении первых признаков смерти.
~ когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, трупных пятен.
~ когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, клинической смерти.
~ когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, клинической смерти.
}

Признаки агонии: {
= затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным, снижением артериального давления, холодная кожа, с бледным или синюшным оттенком.
~ затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания.
~ затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое

становится неритмичным, поверхностным, судорожным.

~ затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным, снижением артериального давления.

~ затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится судорожным, снижением артериального давления, холодная кожа, с бледным или синюшным оттенком.

}

«Тройной прием Сафара» для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает {

= голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед, ротовая полость открыта;

~ положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед;

~ положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней;

~ положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней.

}

В основе внезапной коронарной смерти лежит {

~ артериальная гипертензия;

~ гипертрофия желудочков;

= фибрилляция желудочков;

~ централизация кровообращения.

}

Достоверные признаки клинической смерти {

= отсутствие дыхания, отсутствие сердцебиения, отсутствие сознания, расширенные зрачки без реакции на свет;

~ поверхностное и учащенное дыхание, узкие зрачки без реакции на свет, нитевидный пульс;

~ судороги, холодные конечности, тахипноэ, гипотензия;

~ фибрилляция желудочков, пульс малого наполнения, диспноэ, цианоз.

}

Достоверный признак остановки сердца {

~ апноэ;

= отсутствие пульса на сонной артерии;

~ отсутствие сознания;

~ широкий зрачок без реакции на свет.

}

Закрытие вдоха в гортань корнем языка предупреждает {

- = введение воздуховода;
- ~ поворот головы на бок;
- ~ прием Геймлиха.

}

Интенсивное наблюдение за пострадавшими в критическом состоянии включает {

- ~ выполнение мероприятий гигиенического ухода;
- ~ выявление проблем пациента;
- = мониторинг жизненно важных функций;
- ~ определение основных биохимических показателей крови.

}

Искусственное поддержание гемодинамики – это {

- ~ второй этап;
- = первый этап;
- ~ приоритетный этап;
- ~ третий этап.

}

К методам интенсивной терапии не относится {

- ~ ИВЛ;
- = СЛР;
- ~ гемодиализ;
- ~ парентеральное питание.

}

К терминальным состояниям относится {

- ~ биологическая смерть;
- = период агонии;
- ~ постреанимационная болезнь;
- ~ продромальный период.

}

Наличие у больного дыхания при проведении СЛР определяют {

- = наклоном щекой к лицу больного;
- ~ подсчетом дыхательных движений;
- ~ приемом Геймлиха;
- ~ спирометрией.

}

Непрямой массаж сердца проводится в положении {

- ~ лежа на деревянном щите;
- = лежа на спине на твердой поверхности;
- ~ произвольном;

~ с опущенной вниз головой.
}

Норма сатурации в процентах {
~ 80 – 85 %;
~ 85 – 90 %;
~ 90 – 92 %;
= 96 – 99 %.
}

О смерти мозга свидетельствуют результаты {
~ ЭКГ;
~ спирометрии;
~ фонокардиографии;
= электроэнцефалограммы.
}

Основной признак клинической смерти {
= отсутствие пульса
~ нарушение дыхания;
~ патологическое дыхание;
~ снижение температуры тела.
}

Основные мероприятия при выведении из клинической смерти {
~ дать понюхать нашатырный спирт;
~ проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ);
= проведение непрямого массажа сердца и ИВЛ;
~ разгибание головы.
}

Основные признаки клинической смерти {
~ 50% нитевидный пульс на сонной артерии;
~ 50% отсутствие пульса на лучевой артерии;
~ 50% отсутствие пульса на сонной артерии;
~ 50% расширение зрачков.
}

Первый этап реанимационных мероприятий {
~ «тройной прием Сафара»;
~ ИВЛ;
= не прямой массаж сердца;
~ обеспечение проходимости дыхательных путей.
}

Показания для сердечно-легочной реанимации {
~ агония и предагональное состояние;
~ все внезапно развившиеся терминальные состояния;
= клиническая смерть;
~ клиническая смерть и биологическая смерть.
}

При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят {
~ всей ладонью;
~ одним пальцем;
= проксимальной частью ладони;
~ тремя пальцами.
}

Признак биологической смерти {
~ арефлексия;
~ максимальное расширение зрачка;
= симптом «кошачьего зрачка»;
~ фибрилляция желудочков.
}

Признак эффективности реанимационных мероприятий {
~ зрачки широкие;
~ отсутствие пульсовой волны на сонной артерии;
~ отсутствие экскурсий грудной клетки;
= появление самостоятельного дыхания, сужение зрачков.
}

Признаки биологической смерти {
= наличие трупных пятен, помутнение роговицы;
~ отсутствие пульса, дыхания, АД;
~ отсутствие рефлексов роговицы;
~ отсутствие сознания.
}

Продолжительность клинической смерти у взрослого человека в обычных условиях внешней среды {
~ 1 — 2 мин;
~ 10 — 15 мин;
~ 20 мин;
= 3 — 5 мин.
}

Противопоказания для проведения сердечно-легочной реанимации {

~%50%алкоголизм, психические заболевания;
~%50%заведомо неизлечимые заболевания в последней стадии развития;
~%50%старческий возраст;
~%50%травмы, не совместимые с жизнью.
}

Расположение ладони при проведении непрямого массажа сердца {
~ в 5-ом межреберном промежутке слева;
~ на границе верхней и средней трети грудины;
~ на нижней трети грудины;
= на середине грудины.
}

Реаниматология изучает вопрос: {
= диагностики клинической смерти;
~ лечения хронических заболеваний
~ профилактики экстремальных состояний;
~ функционирования основных жизненных систем.
}

Реанимация – это процесс {
~ замещения функции дыхания;
~ защиты пациента от операционной травмы;
~ лечения терминальных состояний;
= оживления организма.
}

Смещаемость грудины к позвоночнику при непрямом массаже сердца у взрослого человека {
~ 1,5 — 2 см;
~ 2 — 4 см;
= 5 см;
~ 7 — 8 см.
}

Состояние, при котором необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации {
~ биологическая смерть;
= клиническая смерть;
~ повреждения, не совместимые с жизнью;
~ терминальная стадия.
}

Стадия терминального состояния, для которой характерны спутанность сознания,

низкое АД или его отсутствие, бледность или цианоз, частое и поверхностное дыхание {

~ агония;

~клиническая смерть;

= предагония;

~ терминальная пауза.

}

Терминальное состояние расценивается как {

~%50%глубокое нарушение жизненно важных функций;

~%50%пограничное состояние между жизнью и смертью;

~%-50%пограничное состояние между нормой и патологией;

~%-50%состояние нарушенного сознания.

}

Тройной прием Сафара обеспечивает {

~ адекватное кровообращение;

~ адекватный уровень АД;

= проходимость дыхательных путей;

~ устойчивое положение туловища.

}

Асфиксическое утопление характеризуется {

~ попаданием воды в желудок;

~ попаданием воды в дыхательные пути;

~ рефлекторной остановкой сердца и дыхания;

= ларингоспазмом;

~ механической асфиксией.

}

Биологическая смерть начинается с гибели {

~ печени;

= клеток коры головного мозга;

~ почек;

~ клеток подкорковых структур головного мозга;

~ сердца.

}

Боль при инфаркте миокарда купируется {

~ антигипертензивными препаратами;

~ спазмолитиками;

~ сердечными гликозидами;

= наркотическими анальгетиками; +

~ десенсибилизирующими препаратами
}

Больному с гипертоническим кризом необходимо придать положение {

~ стоя;
~ лежа с опущенным головным концом;
~ устойчивое боковое положение;
= лежа с приподнятым головным концом; +
~ строго горизонтальное положение
}

Больные, перенесшие анафилактический шок, нуждаются {

~ в вызове участкового врача на дом;
~ в наблюдении в течение 1 часа;
= в немедленной госпитализации;
~ в санаторно-курортном лечении;
~ в амбулаторном лечении.
}

В агональном состоянии реакция зрачка на свет {

~ ослаблена;
= отсутствует;
~ определяется только на яркий свет;
~ не изменена;
}

В критических ситуациях пульс у новорождённого необходимо определять {

~ на лучевой артерии;
= на плечевой артерии;
~ на височной артерии;
~ на сонной артерии;
~ на бедренной артерии.
}

В основе отморожения лежит {

~ расширение сосудов;
= спазм сосудов и угнетение обменных процессов в тканях;
~ улучшение кровоснабжения тканей;
~ усиление обменных процессов в тканях;
~ гиповолемия.
}

В предагональном состоянии пульс определяется: {

~ только на крупных сосудах;
~ только на периферических сосудах;

=на крупных и периферических сосудах;
~ пульс не определяется;
~ все ответы верны.
}

В предагональном состоянии сознание {
~ утрачено;
~ сохранено;
= утрачено частично;
~ сохранено частично;
~ наблюдается ретроградная амнезия.
}

Вздутие эпигастральной области во время проведения ИВЛ свидетельствует {
~ о правильности её выполнения;
~ об эффективности её выполнения;
~ о попадании воздуха в лёгкие;
= о попадании воздуха в желудок;
~ бесполезности и безнадёжности ИВЛ.
}

Во время лыжной прогулки в морозный день у мужчины на щеке появилось белое пятно, в области которого нет чувствительности при прикосновении пальцев. В этом случае необходимо {
~растереть снегом место поражения;
~ растереть щёку варежкой;
=согреть (приложить ладонь) пораженный участок;
~ растереть спиртосодержащей жидкостью поражённый участок;
~ приложить холодный компресс.
}

Возможное осложнение перелома рёбер {
~пневмония;
=пневмоторакс;
~асфиксия;
~гиперкапния;
~тампонада сердца.
}

Гемоторакс – это попадание в плевральную полость {
~ воды;
= крови;
~ экссудата;
~ транссудата;

~ воздуха
}

Гипертонический криз – это состояние, характеризующееся {
~ потерей сознания;
~ резким понижением АД;
= резким повышением АД;
~ непроизвольным мочеиспусканием;
~ судорогами.
}

Голова пациента с носовым кровотечением при оказании неотложной помощи должна быть {
~ повёрнута влево;
= опущена вниз, подбородок прижат к груди;
~ повернута вправо;
~ запрокинута назад;
~ не имеет значения.
}

Для II степени электротравмы характерно {
~ судорожное сокращение мышц без потери сознания;
= судорожное сокращение мышц с потерей сознания;
~ судорожное сокращение мышц с потерей сознания и сердечными или легочными нарушениями;
~ клиническая смерть;
~ некроз тканей.
}

Для клинической смерти характерны все симптомы, кроме одного {
~ отсутствие сердцебиения;
= сужение зрачков;
~ цианоз или бледность кожных покровов;
~ расширение зрачков;
~ отсутствие дыхания
}

Для оказания неотложной помощи при носовом кровотечении необходимо приготовить {
~ грелку;
= пузырь со льдом;
~ раствор фурацилина;
~ 70% этиловый спирт;
~ согревающий компресс.
}

Для отморожения III степени характерно {
~ побледнение кожи с потерей чувствительности;
~ кожа багрово-синяя, отёк, пузыри с прозрачной жидкостью;
= сильные боли, пузыри с темно-красной или бурой жидкостью;
~ пузыри с черной жидкостью;
~ небольшая припухлость, жжение.
}

Женщина 63-х лет жалуется на сильную головную боль, боль в сердце. Лицо пациентки одутловато, веки отёчны, АД 180/120 мм рт. ст. Определите неотложное состояние {
~ приступ стенокардии;
= гипертонический криз;
~ сердечная астма;
~ инфаркт миокарда;
~ отёк легких.
}

Женщина доставлена в травмпункт с закрытым переломом верхней трети большеберцовой кости и средней трети правого бедра. Сколько суставов необходимо фиксировать при иммобилизации? {
= три;
~ два;
~ четыре;
~ один;
~ в зависимости от наличия количества шин.
}

Кратковременная потеря сознания, связанная с уменьшением притока крови к головному мозгу называется {
~ коллапсом;
~ шоком;
= обмороком;
~ гипертоническим кризом;
~ эпилептическим приступом.
}

Критерий правильности выполнения непрямого массажа сердца {
= появление пульсовых волн на общей сонной артерии при проведении компрессий;
~ появление самостоятельного пульса на общей сонной артерии;
~ повышение артериального давления на периферических артериях;
~ появление самостоятельного дыхания;
~ по изменению цвета кожных покровов.

}

Критерий эффективности непрямого массажа сердца {

~ появление пульсовых волн на общей сонной артерии при проведении компрессий;

= появление самостоятельного пульса на общей сонной артерии;

~ повышение артериального давления на периферических артериях;

~ появление самостоятельного дыхания;

~ изменение цвета кожных покровов.

}

Максимальное время проведения СЛР {

~ 5 минут;

= 30 минут;

~ 1 час;

~ 2 часа;

~ 45 минут.

}

Назовите один из дополнительных симптомов клинической смерти {

~ отсутствие дыхания;

~ отсутствие сознания;

= полное расслабление всей гладкой и поперечнополосатой мускулатуры; +

~ отсутствие кровообращения;

~ симптом «кошачьего глаза».

}

Назовите один из основных симптомов клинической смерти {

= отсутствие дыхания;

~ отсутствие артериального давления на периферических сосудах;

~ симптом «кошачьего глаза»;

~ трупные пятна;

~ мертвенно бледная окраска кожи.

}

Ожоговая поверхность при химических ожогах промывается холодной проточной водой в течение {

= 15-20 минут;

~ 5 минут;

~ 45 минут;

~ 60 минут;

~ 5-10 минут.

}

Тема: Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечения. Десмургия. Виды повязок.

Раны по происхождению подразделяют на: {

- ~%33.33333% бытовые;
 - ~%50% случайные;
 - ~%50% операционные;
 - ~%33.33333% производственные;
 - ~%33.33333% сельскохозяйственные.
- }

Признаки «свежей» раны: {

- ~%33.33333% потеря сознания;
 - ~%50% кровотечение;
 - ~%33.33333% понижение температуры;
 - ~%33.33333% повышение температуры;
 - ~%50% нарушение функции поврежденного участка тела.
- }

Признаки «свежей» раны: {

- ~%33.33333% потеря сознания;
 - ~%50% «зияние» раны;
 - ~%50% боль;
 - ~%33.33333% понижение температуры;
 - ~%33.33333% повышение температуры.
- }

Через рану в организм могут проникать возбудители: {

- ~%50% газовой гангрены;
 - ~%33.33333% ботулизма;
 - ~%50% столбняка;
 - ~%33.33333% острой пневмонии;
 - ~%33.33333% цистита.
- }

Виды кровотечения: {

- ~%50% наружное;
 - ~%33.33333% закрытое;
 - ~%33.33333% открытое;
 - ~%50% внутреннее;
 - ~%33.33333% клапанное
- }

Виды кровотечений: {

~%-33.33333% аортальное;
~%50% артериальное;
~%50% венозное;
~%-33.33333% печеночное;
~%-33.33333% геморрагическое.
}

Симптомы артериального кровотечения: {
~%50% кровь ярко-алого цвета;
~%-33.33333% кровь вишневого цвета;
~%50% пульсирующий ток крови;
~%-33.33333% ток крови не пульсирует;
~%-33.33333% кровь вытекает в виде капель, как из губки.
}

Симптомы венозного кровотечения: {
~%-33.33333% кровь ярко-алого цвета;
~%50% кровь вишневого цвета;
~%-33.33333% пульсирующий ток крови;
~%50% ток крови не пульсирует;
~%-33.33333% кровь вытекает в виде капель, как из губки.
}

Симптомы артериального кровотечения: {
~%-33.33333% пульс ниже места кровотечения прощупывается;
~%50% пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен;
~%50% образующаяся подкожная гематома пульсирует;
~%-33.33333% образующаяся подкожная гематома не пульсирует;
~%-33.33333% кровь вытекает как из губки.
}

Симптомы венозного кровотечения: {
~%50% пульс ниже места кровотечения прощупывается;
~%-33.33333% пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен;
~%-33.33333% образующаяся подкожная гематома пульсирует;
~%50% образующаяся подкожная гематома не пульсирует;
~%-33.33333% кровь вытекает, как из губки.
}

Признаки капиллярного кровотечения: {
~%50% возникает при повреждении поверхностных слоев кожи;
~%-33.33333% кровь вишневого цвета;
~%-33.33333% пульсирующий ток крови;
~%-33.33333% ток крови не пульсирует;

~%50% кровь вытекает в виде капель, как из губки.
}

Паренхиматозное кровотечение возникает при ранении: {
~%-33.33333% желудка;
~%-33.33333% кишечника;
~%50% печени;
~%50% селезенки;
~%-33.33333% мочевого пузыря.
}

Способы остановки паренхиматозного кровотечения: {
~ наложение жгута;
~ наложение давящей повязки;
~прижатие к кости;
~ максимальное сгибание конечности;
=только хирургическим путем.
}

Способы остановки венозного кровотечения: {
~ наложение жгута;
= наложение давящей повязки;
~прижатие к кости;
~ придать конечности возвышенное положение;
~только хирургическим путем.
}

Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают на: {
~%-33.33333% кисть;
~%-33.33333% предплечье;
~%50% среднюю или верхнюю треть плеча;
~%-33.33333% середину голени;
~%50% среднюю треть бедра.
}

Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: {
~%33.33333% побледнение кожи конечности;
~%-25% конечность приобретает багрово-синюшную окраску;
~%-25% уменьшение кровотечения;
~%33.33333% прекращение кровотечения;
~%33.33333% пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;
~%-25% пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения;
~%-25% усиление кровотечения.
}

Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет ... часов: {

= 0,5;

~ 1,0;

~ 1,5;

~ 2,0;

~ 2,5.

}

Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута летом составляет ... часов: {

~ 0,5;

= 1,0;

~ 1,5;

~ 2,0;

~ 2,5.

}

Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: {

~ венозном;

= артериальном;

~ капиллярном;

~ паренхиматозном;

~ внутреннем.

}

Для жгута-закрутки можно использовать: {

~%50% галстук;

~%-33.33333% бельевую веревку;

~%-33.33333% шпагат;

~%50% мягкий шарф;

~%-33.33333% телефонный провод.

}

Колосовидная повязка накладывается на ... сустав: {

~ локтевой;

~ лучезапястный;

~ тазобедренный;

~ голеностопный;

= плечевой.

}

На волосистую часть головы накладывается ... повязка: {

~ колосовидная;

- ~ восьмиобразная;
- ~ спиральная;
- ~ круговая;
- = «чепец».

}

Правильно наложенная повязка: {

- ~%33.33333% хорошо закрывает поврежденную часть тела;
- ~%-25% вызывает побледнение кожных покровов;
- ~%-25% вызывает цианоз (синюшность) кожных покровов;
- ~%33.33333% не вызывает нарушения кровообращения;
- ~%33.33333% прочно удерживается на теле;
- ~%-25% легко сползает;
- ~%-25% вызывает отек тканей.

}

При ранении артерий кисти кровоостанавливающий жгут накладывают на: {

- ~ область лучезапястного сустава;
- ~ среднюю треть предплечья;
- ~ верхнюю треть предплечья;
- ~ локтевой сустав;
- = нижнюю треть плеча.

}

Кровотечение, возникающее непосредственно после повреждения кро- веносных сосудов: {

- ~ наружное;
- ~ внутреннее;
- = первичное;
- ~ вторичное;
- ~ смешанное.

}

Кровотечение, при котором кровь изливается в ткани, органы или полости организма человека: {

- ~ наружное;
- = внутреннее;
- ~ первичное;
- ~ вторичное;
- ~ смешанное.

}

При ранении грудной клетки может возникнуть: {

- ~%-33.33333% анафилактический шок;

~%50% плевропульмональный шок;
~%-33.33333% плевральный шок;
~%-33.33333% перитонит;
~%50% гемоторакс.
}

При ранении грудной клетки может возникнуть: {
~ анафилактический шок;
~ плевропульмональный шок;
~ плевральный шок;
= пневмоторакс;
~ перитонит.
}

При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают ... повязку: {
~ асептическую;
~ давящую;
= герметизирующую;
~ корсетную;
~ косыночную.
}

Признаки проникающих ранений грудной клетки: {
~%50% наличие раны грудной клетки;
~%50% кровь в ране пузырится;
~%-33.33333% прогрессирующее снижение артериального давления;
~%-33.33333% мелкоочечные кровоизлияния в области грудной клетки и шеи;
~%-33.33333% кровотечение из носа и ушей.
}

Достоверные признаки проникающего ранения органов брюшной полости: {
~%-33.33333% холодный липкий пот;
~%-33.33333% шум в ушах;
~%-33.33333% резкое снижение артериального давления;
~%50% выпячивание или выпадение из раны участка сальника или петли кишки;
~%50% истечение из раны содержимого желудка, кишечника, мочи или желчи.
}

При ранении артерий кисти кровоостанавливающий жгут накладывают на: {
~ область лучезапястного сустава;
~ среднюю треть предплечья;
~ верхнюю треть предплечья;
~ локтевой сустав;
= верхнюю треть плеча.
}

Признаки острой кровопотери: {

~ высокое артериальное давление, учащенное дыхание;

~ высокое артериальное давление, частый пульс;

= низкое артериальное давление, частый нитевидный пульс;

~ сонливость, бледность, редкий пульс;

~ гиперемия кожных покровов, кома.

}

В случаях артериального кровотечения необходимо {

~%50% прижать пальцами или кулаком артерию, наложить
кровоостанавливающий жгут

~%-50% освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить
кровоостанавливающий жгут

~%-50% жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин

~%50% жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час

}

При проникающем ранении груди, следует: {

~%50% прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить
герметичную повязку.

~%-50% Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку

~%-50% Транспортировку производить только в положении «лежа»

~%50% транспортировку производить только в положении «сидя»

}

При ранении конечностей необходимо: {

~ промыть рану водой

~ обработать рану спиртовым раствором

= накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или
прикрепить ее лейкопластырем.

~ промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку
или прикрепить ее лейкопластырем

}

При проникающем ранении живота необходимо: {

~%50% прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем.

Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.

~%-33.33333% Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой
салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной
ремень.

~%-33.33333% По возможность дать обильно пить

~%50% транспортировка только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и
согнутыми в коленях ногах

~%-33.33333% транспортировка только в положении «сидя»

}

Признаки артериального кровотечения {

- ~%33.33333% алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
 - ~%33.33333% над раной образуется валик из вытекающей крови
 - ~%33.33333% большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего
 - ~%-50% очень темный цвет крови
 - ~%-50% кровь пассивно стекает из раны
- }

Признаки венозного кровотечения {

- ~%-50% алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
 - ~%-50% над раной образуется валик из вытекающей крови
 - ~%50% очень темный цвет крови
 - ~%50% кровь пассивно стекает из раны
- }

Когда следует накладывать давящие повязки {

- ~%50% при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны
 - ~%50% сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания
 - ~%-50% большое кровавое пятно на одежде
 - ~%-50% над раной образуется валик из вытекающей крови
- }

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут {

- ~%33.33333% алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
 - ~%33.33333% над раной образуется валик из вытекающей крови
 - ~%33.33333% большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего
 - ~%-50% сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания
 - ~%-50% при укусах ядовитых змей и насекомых
- }

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении {

- ~не более чем на 0,5 часа
 - =не более чем на 1 час
 - ~не более чем на 1,5 часа
 - ~не более чем на 2 часа
 - ~не более чем на 3 часа
- }

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: {

~освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.
=остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет «Скорая помощь», контролировать пульс за медиальной лодыжкой.
~остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке
~освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа
}

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки {
=прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении
~прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине
~прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине
~прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении
~прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении
}

В каком случае следует накладывать давящую повязку {
=при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны
~алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
~большое кровавое пятно на одежде
~в случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей
}

Признаки венозного кровотечения {
~ кровь пассивно стекает из раны
~ над раной образуется валик из вытекающей крови
= очень темный цвет крови
~ алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
}

Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? {
~ Непосредственно на рану.

- ~ Ниже раны на 4-6 см.
- ~ Выше раны на 4-6 см.
- = Туда где одна кость, максимально близко к ране
- }

При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается: {

- ~ С наложения импровизированной шины
- = С наложения жгута выше раны на месте перелома
- ~ С наложения давящей повязки
- ~ С максимального сгибания конечности в суставе
- }

Признаки артериального кровотечения {

- ~%-50%очень темный цвет крови
- ~%33.33333%алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
- ~%33.33333%большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего
- ~%33.33333%над раной образуется валик из вытекающей крови
- ~%-50%кровь пассивно стекает из раны
- }

В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? {

- = Остановка кровотечения, наложение повязки
- ~ Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения
- ~ Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки
- ~ Обеззараживание раны, наложение повязки
- }

Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до прибытия бригады скорой медицинской помощи? {

- ~%33.33333% если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут
- ~%-100%промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать
- ~%33.33333% наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать
- ~%33.33333% обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи
- }

Для временной остановки артериального кровотечения необходимо выполнить следующие действия: {

- = осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку на рану, при необходимости наложить кровоостанавливающий жгут;
 - ~ наложить кровоостанавливающий жгут;
 - ~ наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в медицинскую организацию;
 - ~ зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут.
- }

Выберите основные способы остановки кровотечения при ранении головы: {

- = прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
 - ~ наложение давящей повязки, пальцевое прижатие сонной артерии;
 - ~ пальцевое прижатие сонной артерии, наложение давящей повязки с использованием жгута;
 - ~ применение холода в области ранения, пальцевое прижатие сонной артерии.
- }

При проникающем ранении груди самое важное – это: {

- ~ попытаться остановить кровотечение давящей повязкой;
 - ~ не прикасаться к ране во избежание причинения вреда;
 - = наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух;
 - ~ своевременно обезболить пострадавшего;
 - ~ постоянно контролировать дыхание и кровообращение пострадавшего;
 - ~ придать пострадавшему устойчивое боковое положение.
- }

Признаки кровопотери – это все, кроме следующего: {

- ~ резкая общая слабость, чувство жажды;
 - ~ головокружение, мелькание мушек перед глазами;
 - ~ обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная кожа;
 - = урежение частоты сердечных сокращений, снижение частоты дыхания;
 - ~ учащенный слабый пульс, частое дыхание.
- }

Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее: {

- ~ срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь;
- = не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь;
- ~ не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников;
- ~ обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь;
- ~ аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны остановить

путем заполнения ее стерильными салфетками, вызвать скорую медицинскую помощь, положить холод на место ранения.
}

Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения: {
~наложение кровоостанавливающего жгута;
~ наложение давящей повязки;
~ пальцевое прижатие артерии;
= прямое давление на рану.
}

Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается по следующим признакам: {
= визуально по уменьшению или остановке кровотечения;
~ по правильности нахождения точки пальцевого прижатия;
~ по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку прижатия;
~ по сохранению пульса ниже места прижатия.
}

Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется: {
~ в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватывающими бедро;
~ выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, достаточным для остановки кровотечения;
~ в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела;
= в паховой области кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи.
}

Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее положение: {
~ устойчиво боковое положение;
~ полусидячее положение;
= положение на спине с приподнятыми ногами;
~ положение на спине с согнутыми и разведенными ногами;
~ положение на животе.
}

Пальцевое прижатие подмышечной артерии производится: {
= в области плечевого сустава и надплечья к плечевой кости в подмышечной впадине прямыми, жестко зафиксированными пальцами в направлении плечевого сустава;

- ~ давлением кулаком в область подмышечной впадины;
 - ~ большим пальцем к плечевой кости;
 - ~ сильным прижатием плеча к туловищу.
- }

Для остановки венозного кровотечения используются все способы, кроме следующего: {

- ~ прямое давление на рану;
 - ~ наложение давящей повязки на рану;
 - = наложение кровоостанавливающего жгута;
 - ~ максимальное сгибание конечности в суставе;
- }

Пальцевое прижатие подключичной артерии производится: {

- ~ к ключице с помощью четырех пальцев с усилием, достаточным для остановки кровотечения;
 - ~ в ямке под ключицей большим пальцем к первому ребру;
 - ~ указательным и средним пальцем в ямке над ключицей строго перпендикулярно поверхности грудной клетки;
 - = в ямке над ключицей к первому ребру с помощью четырех пальцев.
- }

Пальцевое прижатие плечевой артерии осуществляется: {

- = к плечевой кости с внутренней стороны плеча ниже бицепса с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу;
 - ~ большим пальцем под бицепсом пострадавшего с усилием, достаточным для остановки кровотечения;
 - ~ указательным и средним пальцем примерно посередине наружной поверхности плеча;
 - ~ к плечевой кости с наружной стороны плеча ниже бицепса с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу;
 - ~ пальцами обеих рук, обхватывая плечо в верхней части по окружности.
- }

Признаком венозного кровотечения является: {

- ~ струя крови темного (темно-вишневого) цвета разной интенсивности;
 - ~ кровь, вытекающая из раны по капле;
 - ~ алая пульсирующая струя крови;
 - = выделение темной крови со всей поверхности раны.
- }

Для остановки кровотечения методом максимального сгибания необходимо: {

- ~ наложить кровоостанавливающий жгут на область сустава, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать вручную или другим способом (бинтом, брючным ремнем и т. д.);

= вложить в область сустава 1–2 бинта или свернутую валиком одежду, конечность согнуть и зафиксировать руками, жгутом, несколькими турами бинта или подручными средствами;

~ наложить на рану давящую повязку, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать;

~ согнуть конечность в суставе, зафиксировать табельными или подручными средствами, для усиления эффекта вложить в область сустава твердый предмет (металлическую трубу, кусок дерева и т. д.).

}

Какое положение должен принять пострадавший с носовым кровотечением: {

~ сидя, голова запрокинута;

~ лежа на боку, валик под головой;

= сидя, голову слегка наклонить вперед;

~ лежа на спине, голова запрокинута.

}

Жгут можно ослаблять (снимать) не более чем: {

~ на 10 минут;

~ на 15–30 минут;

= на 15 минут;

~ на 1–2 минуты.

}

При наличии у пострадавшего признаков артериального кровотечения необходимо выполнить следующее: {

~ осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавливающий жгут;

~ выполнить наложение кровоостанавливающего жгута, на рану наложить давящую повязку;

= осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить кровоостанавливающий жгут выше раны;

~ осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавливающий жгут, на рану наложить давящую повязку.

}

При подробном осмотре у пострадавшего обнаружена рана на голове с обильным кровотечением темной кровью, пострадавший в сознании. С чего следует начать оказывать первую помощь: {

= положить на рану марлевую салфетку из аптечки, аккуратно придавить;

~ придать пострадавшему устойчивое боковое положение;

~ приложить холод к голове;

- ~ вызвать скорую медицинскую помощь;
 - ~ наложить на голову повязку типа «чепчик».
- }

Пострадавшему с ранением плеча и сильным венозным кровотечением была наложена давящая повязка на рану. Спустя 0–15 минут повязка пропиталась кровью. Что следует сделать: {

- ~ удалить старую повязку, наложив на ее место новую;
 - = наложить новую повязку поверх старой;
 - ~ не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут;
 - ~ сняв старую повязку, плотно затампонировать рану салфетками марлевыми, после чего повторно наложить давящую повязку.
- }

При оказании первой помощи пострадавшему в сознании с сильно кровоточащей раной в области голени необходимо: {

- ~ вызвать скорую помощь, уложить на спину пострадавшего, обрызгать лицо холодной водой, согреть пострадавшего
 - = вызвать скорую помощь, наложить жгут, поднять ноги и опустить головной конец пострадавшего, приложить холод к повязке.
 - ~ вызвать скорую помощь, поднести ватный шарик с нашатырным спиртом к носу пострадавшего, перенести пострадавшего на мягкое место, наложить давящую повязку
 - ~ уложить пострадавшего на бок, наложить давящую повязку, приложить холод
- }

При наложении кровоостанавливающего жгута необходимо: {

- = накладывать жгут на одежду или специальную ткань
 - ~ освободить конечность от одежды
 - ~ запомнить самому время наложения жгута
 - ~ попросить пострадавшего запомнить время наложения жгута
- }

Признаками артериального кровотечения являются: {

- ~ на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови.
 - ~ кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и непрерывной струей.
 - = кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей.
 - ~ кровь темно-вишневого цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей
- }

После наложения жгута пишется записка с целью: {

- ~ указания место аварии и фамилии пострадавшего.
- = указания время наложения жгута.

- ~ указания повреждений, обнаруженных у пострадавшего.
- ~ указание фамилии лица, наложившего жгут
- }

Признаками венозного кровотечения являются: {

- ~ на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови.
- = кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной непрерывной струей.
- ~ кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей.
- ~ кровь темно-вишневого цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей.
- }

При оказании первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением надо: {

- ~ пережать сосуд пальцами выше места повреждения.
- ~ наложить жгут выше места повреждения.
- = наложить давящую повязку.
- ~ наложить асептическую повязку
- }

Герметизирующую повязку накладывают при: {

- = проникающем ранении грудной клетки.
- ~ проникающем ранении живота.
- ~ черепно-мозговой травме.
- ~ при переломе конечностей
- }

Укажите основное мероприятие первой помощи при носовом кровотечении: {

- ~ охладить пораженный участок тела
- = приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
- ~ остановить кровотечение
- ~ наложить давящую повязку
- ~ доставить в теплое место
- ~ наложить шину
- }

Укажите основное мероприятие первой помощи при ранении: {

- ~ охладить пораженный участок тела
- ~ приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
- = остановить кровотечение
- ~ наложить давящую повязку
- ~ доставить в теплое место
- ~ наложить шину
- }

Укажите основное мероприятие первой помощи при ране головы с кровотечением:

{

~ охладить пораженный участок тела

~ приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз

~ остановить кровотечение

= наложить давящую повязку

~ доставить в теплое место

~ наложить шину

}

При промокании давящей повязки на конечности нужно: {

~ снять предыдущую и наложить новую

~ ничего не делать

= наложить давящую повязку не снимая предыдущую

~ наложить жгут

}

На этапе первой помощи основная профилактическая мера по предупреждению дальнейшего инфицирования раны является: {

~ смазывание краев раны жировым веществом

~ иссечение краев раны

~ наложение жгута выше раны

~ срочное ушивание раны

= наложение повязки из чистой ткани

}

Необходимо наблюдать пострадавшего с подозрением на внутреннее кровотечение, опасное для жизни, при ушибах частей тела: {

~%50% живот

~%50% грудь

~%-50% нога

~%-50% лицо

}

Кровотечение из раны конечности пульсирующей струей останавливают: {

~%33.33333% живот прижатием артерии по её ходу

~%33.33333% наложением жгута

~%-50% прикладыванием холода

~%-50% поднятием конечности

~%33.33333% наложением давящей повязки

}

Какие изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран должны быть обязательно в аптечке? {

= стерильные салфетки, различные бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут
~ бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут
~ бинты различной ширины, вата и лейкопластырь
~ бинты, салфетки, жгут и вата
}

Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов? {
~ промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать рану настойкой йода.
~ обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные предметы.
= нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны.
~ обработать рану спиртовым раствором, затем удалить инородные тела
}

Каким образом производится наложение кровоостанавливающего жгута на конечность? {
~ жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения, конечность фиксируется повязкой
= жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения на подкладочный материал.
~ жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения непосредственно на кожу.
~ жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения на подкладочный материал.
}

Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? {
= кровотечение прекращается, конечность бледнеет, отсутствует пульсация.
~ пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности.
~ развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, наполненные жидкостью.
~ кровотечение прекращается, пульс определяется
}

С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную верхнюю конечность согнутой к туловищу? {
= косыночной.
~ пращевидной.
~ спиральной.
~ колосовидной
}

По анатомической классификации различают следующие виды кровотечений: {

~%50% артериальные, венозные
~%50% капиллярные, паренхиматозные
~%-50% легочные, желудочные
~%-50% носовые
}

При ранении вен шеи необходимо: {
~ наложить тугую давящую повязку
~ применить пальцевое прижатие сосуда
= наложить тугую давящую повязку с противоупором со здоровой стороны
~ затампонировать рану подручными средствами
}

Укажите характеристику легочного кровотечения: {
~ внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту
= внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта
~ внезапная рвота «кофейной гущей»
~ внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»
}

При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной должен находиться в положении ... {
~ лежа вполоборота
= сидя
~ в любом удобном для него
~ лежа на спине
}

Укажите признаки кровотечения из пищевода и желудка: {
~ тошнота, рвота «кофейной гущей»
~ выделение алой, пенистой крови изо рта
= внезапная рвота полным ртом темной жидкой крови
~ отдельные плевки алой кровью
}

При подозрении на перелом ребер тугие повязки на грудную клетку: {
= накладываются в случае окончательного перелома
~ накладываются в случае подозрения на перелом нескольких ребер
~ накладываются обязательно на время транспортировки в лечебное учреждение
~ не накладывают ни в каком случае
}

Первая помощь при артериальном кровотечении: {
~ наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять

подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, тонкая веревка и проволока.

~ наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: бинт, носовой платок, тонкая веревка и проволока.

~ наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, бинт.

= наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, носовой платок.

~ наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, носовой платок, тонкая веревка и проволока.

}

Виды повязок при повреждении черепа: {

~%50% чепец, шапочка, на один глаз, на оба глаза, на ухо, восьмиобразная повязка на затылочную область и шею, на затылок, на теменную область.

~%-50% стерильные чепец, шапочка, на один глаз, на оба глаза, на ухо, восьмиобразная повязка на затылочную область и шею, на затылок, на теменную область, на подбородок.

~%50% повязка сетчато-рубчатым бинтом, шапочка Гиппократ, на нос, на подбородок и нижнюю челюсть (уздечка), контурная повязка на щеку.

~%-50% бинтовые повязка сетчато-рубчатым бинтом, шапочка Гиппократ, на нос, на подбородок и нижнюю челюсть (уздечка), контурная повязка на щеку, на один глаз, на оба глаза, на ухо, на теменную область.

}

Первая помощь при проникающем ранении живота: {

~ на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности направить в брюшную полость, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость.

= на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость.

~ на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость.

~ на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить.

~ на рану наложить стерильную повязку, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость.

}

Признаки проникающего ранения грудной клетки: {

~ затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны.

~ затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, кровохаркание.

~ затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, кровохаркание.

= затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, сильная боль в области раны, кровохаркание.

~ затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, сильная боль в области раны, кровотечение.

}

Укажите последовательность мероприятий первой помощи пострадавшему проникающим ранением живота. В ране находится нож. {

= Вызвать скорую медицинскую помощь; зафиксировать инородное тело и наложить повязку на рану; придать транспортное положение.

~ Аккуратно достать инородное тело; наложить повязку; придать транспортное положение; вызвать скорую медицинскую помощь.

~ Вызвать скорую медицинскую помощь, аккуратно достать инородное тело; наложить повязку; придать транспортное положение.

~ наложить повязку; придать транспортное положение

}

Укажите места наложения пращевидной повязки. {

~%33.333333% Область лба.

~%33.333333% Область носа.

~%-50% Область локтя.

~%33.333333% Область подбородка.

~%-50% Область пятки.

}

При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую очередь: {

~ Обработать край раны йодом;

~ Провести иммобилизацию конечности;

~ Промыть рану перекисью водорода;

= Остановить кровотечение.

}

В каких случаях необходимо соблюдать меры профилактики заражения инфекциями,

передающимися с кровью (ВИЧ-инфекция, гепатиты и др.). {

~ Только при оказании первой помощи ВИЧ-инфицированным лицам.

= При оказании помощи любому пострадавшему.
~ Только при оказании помощи асоциальным лицам.
~ При оказании помощи молодым
}

Укажите препараты, которые можно применить для обработки кожных покровов, загрязненных кровью. {
~%33.33333% этиловый спирт.
~%-100% раствор бриллиантового зеленого.
~%33.33333% спиртовой раствор йода.
~%33.33333% Раствор хлоргексидина.
}

При случайном попадании крови пострадавшего на слизистую оболочку полости рта спасающего необходимо: {
~%-50% Прополоскать рот водой.
~%-50% Обработать 5 % спиртовым раствором йода.
~%50% Прополоскать рот 70 % раствором этилового спирта.
~%50% Прополоскать рот раствором хлоргексидина.
}

Положение, придаваемое пострадавшему с ранением грудной клетки: {
~ горизонтальное
~ горизонтальное, голова повёрнута в сторону
= полусидячее
~ лёжа на боку
}

Транспортировка пострадавших при лёгочном кровотечении: {
~ горизонтальное
~ горизонтальное, голова фиксирована и повёрнута в сторону
= полусидячее
~ лёжа на боку
}

Транспортировка пострадавших при желудочно-кишечном кровотечении: {
= горизонтальное
~ лёжа на щите
~ полусидячее
~ сидя
}